

Dissosiyatif Bozukluklar

Dissosiyatif bozukluklar, kişinin benlik algısı, hafızası, duyguları, bedeni ve çevresiyle olan bütünlük duygusunda bozulmalar yaşadığı karmaşık ruhsal bozukluklardır. Bu bozukluklarda kişi zaman zaman kendisini dışarıdan izliyormuş gibi hissedebilir, bedeninin veya duygularının kendisine ait olmadığı düşüncesine kapılabilir, çevresini gerçek dışı algılayabilir ya da bazı anılara ulaşmakta güçlük çekebilir. Özellikle travmatik yaşantılarla ilişkili durumlarda bu belirtiler, kişinin yaşadığı yoğun duygusal deneyimlerden zihinsel olarak uzaklaşmasına hizmet eden bir savunma biçimi olarak değerlendirilmektedir.

Dissosiyatif bozuklukların anlaşılmasında beyin benlik, duygu, hafıza ve bilişsel kontrol sistemleri arasındaki etkileşimler önem taşımaktadır. Fonksiyonel nörogörüntüleme çalışmalarında dissosiyatif bozukluğu olan bireylerin beyin aktivitelerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğu ve bu farklılıkların tek bir beyin bölgesiyle sınırlı olmadığı gösterilmiştir. Özellikle prefrontal korteks, anterior singulat korteks, limbik sistem, amigdala, hipokampus, parahipokampal girus, insula ve talamus gibi bölgelerde değişiklikler bildirilmiştir.

Depersonalizasyon açısından dikkat çekici bulgulardan biri, kişinin kendi yüzünü tanımasından çok, bu yüzün “kendisine ait olduğu” hissinin işlenmesinde farklılık bulunabileceğini düşündürmektedir. Kişi aynada gördüğü kişinin kendisi olduğunu bilmesine rağmen, kendisini yabancı, uzak veya duygusal olarak kopuk hissedebilir. Kendi yüzü ile yabancı yüzlerin işlendiği fMRI çalışmalarında sağ anterior singulat korteks ile medial prefrontal kortekste artmış aktivasyon görülmesi, kişinin kendisiyle ilgili bilinçli ve bilinçdışı işlemleri arasında bir çatışma olabileceğini düşündürmektedir. Depersonalizasyonun şiddetinin medial prefrontal korteksteki aktivasyonla ilişkili bulunması da bu bağlantıyı desteklemektedir.

Bunun yanında, duygusal yüz ifadelerine verilen limbik yanıtların azalması önemli bir başka bulgudur. Amigdala ve diğer limbik yapılardaki düşük aktivasyon, kişinin duyguları normal biçimde deneyimleyememesi veya duygularına karşı bir çeşit uzaklık hissetmesiyle ilişkili olabilir. Bu nedenle dissosiyasyon yalnızca “kendini farklı hissetme” değil; duygunun, benlik algısının ve bedensel deneyimin birbirleriyle olan bağlantısının değişmesi şeklinde de düşünülebilir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu’nda (DID) ise bu farklılıklar daha belirgin ve karmaşık bir örüntü göstermektedir. Çalışmalarda, kişinin farklı kimlik durumlarında beyin aynı şekilde çalışmadığı; travmayla ilişkili kimlik durumu ile görünüşte normal kimlik durumu arasında farklı beyin aktivasyonları oluşabildiği görülmüştür. Travmatik anıların yeniden canlandırıldığı durumlarda amigdala, insula, parahipokampal girus ve kaudat gibi bölgelerde değişiklikler gözlenirken, bazı travmatik

kimlik durumlarında prefrontal korteks ve çalışma belleğiyle ilişkili bölgelerde aktivasyonun azalması bildirilmiştir. Buna karşılık nötr durumlarda bazı prefrontal ve parietal bölgelerde artmış aktivasyon görülebilmesi, dissosiyatif beyin genel olarak “daha az çalıştığını” değil, farklı durumlarda farklı biçimde çalıştığını düşündürmektedir.

Bu bulgular özellikle travma, hafıza ve duygusal düzenleme arasındaki ilişkiyi anlamak açısından önemlidir. Örneğin hipokampus ve parahipokampal bölgeler otobiyografik hafıza ile ilişkilirken, amigdala duygusal ve tehdit içeren bilgilerin işlenmesinde; insula ise bedenin içsel duyularının ve duygusal durumların fark edilmesinde rol oynar. Bu sistemlerdeki farklı aktivasyonlar, travmatik deneyimlerin neden bazen yoğun biçimde yeniden yaşanırken bazen de kişiden kopuk, uzak veya erişilemez hissedilebildiğini açıklamaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, dissosiyatif bozuklukları “kişinin gerçeklikten kopması” veya “bir şeyleri unutması” şeklinde basitleştirmek doğru değildir. Mevcut nörogörüntüleme bulguları, kişinin “Ben kimim?”, “Bu beden bana mı ait?”, “Bu duygu gerçekten benim mi?” ve “Bu anı bana mı ait?” gibi temel öznel deneyimlerinin oluşmasında rol oynayan beyin ağlarının farklı biçimde çalışabileceğini düşündürmektedir. Ancak mevcut çalışmaların çoğunda

örneklem sayılarının küçük olması ve kullanılan yöntemlerin farklılık göstermesi nedeniyle bu bulgular kesin bir neden-sonuç ilişkisi olarak değerlendirilmemelidir. Yine de genel tablo oldukça dikkat çekicidir: Dissosiyasyon, yalnızca zihinsel bir “unutma” hali değil; benlik, duygu, beden ve hafızayı bir bütün halinde deneyimlemeyi sağlayan süreçlerin değişmesiyle ilişkili karmaşık bir nörobiyolojik durumdur.

Kaynaklar:

1) Purcell JB, Brand B, Browne HA, Chefetz RA, Shanahan M, Bair ZA, Baranowski KA, Davis V, Mangones P, Modell RL, Palermo CA, Robertson EC, Robinson MA, Ward L, Winternitz S, Kaufman ML, Lebois LAM. Treatment of dissociative identity disorder: leveraging neurobiology to optimize success. *Expert Rev Neurother*. 2024 Mar;24(3):273-289. doi: 10.1080/14737175.2024.2316153. Epub 2024 Feb 15. PMID: 38357897; PMCID: PMC10950423.

2) Modesti MN, Rapisarda L, Capriotti G, Del Casale A. Functional Neuroimaging in Dissociative Disorders: A Systematic Review. *J Pers Med*. 2022 Aug 29;12(9):1405. doi: 10.3390/jpm12091405. PMID: 36143190; PMCID: PMC9502311

Ali Bocakkıtaç/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University